



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : فيفي سابا نخله فام
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : المعصره
رقم البطاقة : 26312230103542 رقم التليفون : 01287423255
العنوان : المعصره
العمر (تاريخ الميلاد) : 23-12-1963 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فيفي سابا نخله فام National ID: 26312230103542	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

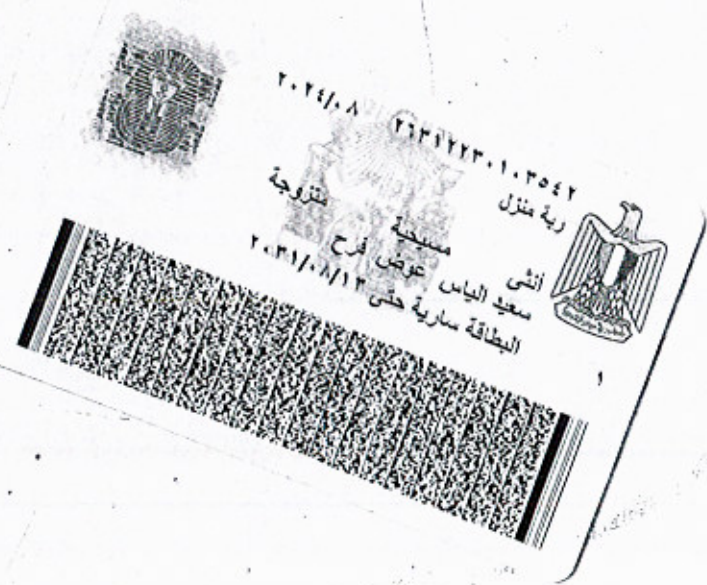
التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

DMS

أوصيتا ←
تدعى ←



~~٦٦٣٣١٠٦٥ هرون~~
~~٦٦٣٣١٠٧٦ تدعى~~



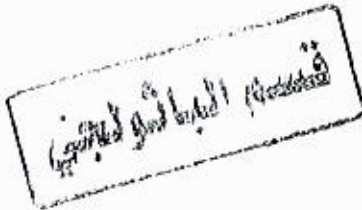
Patient Name الأستاذة / فيفي سابا نخلة فام
Patient No. 26312230103542
Path No. 3284/22
Sex Female
Age 58 Y
Referring Doc.

Request No. 13005681
Request Date 03/11/2022
Verification Date 19/11/2022
Financial Category أورام دار السلام - نفقة الدولة
Department Out Patient
Registered by .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

HER2 : Positive (score3+)
Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

Prof.Gamal Abdelatty
Dr.Marwa Mahmoud
Dr.Ameen Ahmed



Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 19/11/2022 15:57:27

Page 2 of 2

Printed By : dr.esraa magdy

Patient Name	: الأستاذة / فيفي سايما نخله فام	Request No.	: 13005681
Patient No.	: 26312230103542	Request Date	: 03/11/2022
Path No.	: 3284/22	Verification Date	: 14/11/2022
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 58 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data:

Left breast lesion

Nature of specimen:

Tru cut biopsy, collected at 2/11/2022 , 11:13 am

Gross examination

Multiple greyish white & yellowish tissue cores up to 2 cm , totally submitted.

Microscopic examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma .
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+1) Grade II
- * DCIS: Could not be detected within the limits of biopsy recieved
- * Angioinvasion: Could not be detected within the limits of biopsy recieved

Diagnosis:

Left breast lesion, tru cut biopsy:

Invasive duct carcinoma, Grade II .

For further IHC (ER,PR,HER2,Ki67)

Prof.Gamal abdelatty

Dr.Marwa Mahmoud

Verified by :

Printing Date : 30/06/2023 10:06:11

Page 1 of 1

Printing By : .marwa mohamed youss



شرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Patient Name : الأستاذة / فيفي ساهبا نخله قام :	Request No. : 13005440
Patient No. : 26312230103542	Request Date : 11/12/2022
Path No. : 3741/22	Verification Date : 28/12/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age : 58 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer

Nature of the specimen : Left BCS & Left SLN biopsy

Gross Examination:

- Procedure: Left BCS specimen measured 13x7x4 cm , covering skin ellipse measured 5x1.5 cm .
- Tumor extent : A well defined greyish white firm mass measured 1.5x1.5 cm .
- Distance from margins: 1cm away from least margin (deep).
- SLNS : A fibrofatty tissue piece measured 5x5 cm enclosing 7 LNs up to 1.5x1 cm.
- Frozen section: Free margins & Free SLNs (0/7)

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): GII(3+2+1).
- Ductal carcinoma in situ: Focal (<5%) (non comedo).
- Perineural invasion: Positive.
- Peritumoural lymphovascular emboli: No.
- Lymph node involvement: Free SLNs (0/7).
- Resection Margins: Free margins.

Diagnosis:

Left BCS & Left SLN biopsy:

- Invasive duct carcinoma Grade II with focal DCIS.
- Free SLNs (0/7).
- Free margins & Free skin.
- Stage : pT1 , pN0, pMx.

Prof. Dr. Lubna Omer

Verified by :

DR.Menna Nabil



Patient Name : الأستاذة / فوفى مينا نخله فام
Patient No. : 26312230103542
Path No. : 3741/22
Sex : Female
Age : 58 Y
Referring Doc :

Request No. : 13005440
Request Date : 11/12/2022
Verification Date : 28/12/2022
Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Dr. Ameen Ahmed.

Verified by :
DR.Menna Nabil

Printing Date : 28/12/2022 11:43:57

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



Patient Name: Fifi Saba Nakhla Fam	Date : 09/12/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 61 Year(s)
Medical ID: ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Pat. ID: 23835

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH
RESOLUTION ULTRASOUND**

Indication:

- Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

Left breast:

- UQ operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable masses.
- No suspicious micro calcifications.
- No sizable collection.
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Right Breast:

- ACR C with adenosis pattern.
- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Few scattered benign calcific foci.
- No spiculated mass lesions.
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Right breast : fibroadenosis (BIRADS 2).

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



Patient Name: Elt Saba Nakhla Fam	Date: 26/11/2022
Exam: CT ABDOMEN & PELVIS WITH CONTRAST	Age: 59 Year(s)
Medical ID:	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -
Findings:

I Chest:-

- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- Enlarged liver with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic ascites.
- No suspicious lytic or sclerotic lesions.

Opinion:

- No pulmonary, hepatic or osseous metastatic deposits.
- Fatty hepatomegaly.

Dr. Aya Deabes, MSc.

~~Dr. Ola Magdy, M.D.~~